

Fecha Última Actualización: 04-05-2023 17:23:24

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Lidia Del Carmen Quintana García
Edad : 66a 3m 29d
Dirección : Francisco De Asis 2182 Galilea

Rut : 8.231.527-6
Fecha Nacto: 05/01/1957
Comuna : Rancagua

N° Archivo : 2221849
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 7710 0448

N° Epicrisis
351730

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Traumatología Y Ortopedia
Unidad de Egreso : Traumatología Y Ortopedia

Fecha Ingreso : 28/04/2023 14:53
Fecha Egreso : 04/05/2023 17:05

Días Estadía: 6

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dolor lumbar.

Comorbilidades

Hipotiroidismo; Dhc;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Fijación De Columna (Cervical-Dorsal-Lumbar) Cualquier Vía Abordaje, C/S Osteosíntesis. - 02/05/2023 00:00 - Cristhopher Mazuret Sepulveda

Epidemiología

Resumen Clínico

AM: HIPOTIROIDISMO, DHC CON TRANSPLANTE HEPATICO 12/22
ALERGIAS: NO

PACIENTE DERIVADA DESDE CDT DE TRANSPALNTES. HAB IAN SOLICITADO TAC LUMBAR POR DOLOR DE 3 SEMANAS DE EVOLCUION, SE ENCUENTRA FRACTURA OF5 T12, SE INGRESA PARA MANEJO QX

SE RECIBE PACIENTE DESDE CDT, SE CONVERSA CASO CON DR BENITEZ, PRESENTA PACIENTE Y SEÑALA QUE ESTA NO TIENE CONTRAINDICACION PARA USO DE ANALGESIA Y ANTICOAGULANTES, INDICA MANTENER TTO INMUNOSUPRESOR.

PACIENTE CON HISOTRIA DE 3 SEMASN DE EVOLUCIOON DE DOLOR LUMABR Y CAIDA A NIVLE HACE 1 SEMANA GOLPEÁNDOSE EN ZONA LUMBAR. SIN ANESTESAI EN SILLA DE MONTAR NI DISFCUNCION MICCIONAL NI DE LA MARCHA.

Funcionalidad

Índice Barthel 85/100 à requiere ayuda aseo personal, ducha, subir/bajar escaleras

Lawton 2/8 à contesta llamadas telefónicas, capaz de cocinar con supervisión, administra dinero, no es capaz de realizar compras por si sólo

Cognitivo

Cuestionario Pfeiffer ¿ 4 errores

Queja de memoria por parte de pareja, refiere olvidos no patológicos

Se realiza cirugía sin incidentes

Buena evolucion post quirurgica, leve dolor en zona operatoria, aposito limpio y seco. sin requerimientos de O2 ni nuevos episodios de desaturacion. Se solicita rx control, la que se encuentra dentro de parametros esperados.

pcte. con buena evolcuion hospitalaria, en condiciones de alta.

Fecha Epicrisis : 04/05/2023 17:23

Página 1 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:23

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Diagnóstico de Egreso

Fractura de columna dorsal -

FRACTURA DE LA COLUMNA VERTEBRAL, NIVEL NO ESPECIFICADO - fractura OF 5 vertebra D12

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

pcte. con buena evolución hospitalaria, se mantiene con su condición neurológica de base, no generando complicaciones. hemodinámicamente estable, afebril, no refiriendo dolor, kinesioterapia ine tolerada. radiografía de control, dentro de parámetros esperados.

Plan Post Alta

reposo relativo, no hacer fuerza

regimen comun

mantener medicacion de transplante hepatico indicado por hepatologia

No quitar parche, si se sale o daña acudir a consultorio

Analgesia:

Celecoxib 200 mg cada 12h en caso de dolor

tramadol 50 mg cada 12h en caso de dolor que no cede a celcoxib

Re consultar en servicio en caso de secrecion abundante por herida, salida de pus, fiebre, desorientacion o en caso de presentar otros signos de alarma (se explica)

Control en CDT columna en 2 semanas con Dr Mazuret.

Control en 1 semana policlinico de hepatologia con realizacion de exámenes previos a control.

BILIRRUBINA (TOTAL Y DIRECTA), CREATININA EN SUERO, FOSFATASA ALCALINA (ALP), GAMMA-GLUTAMIL-TRANSFERASA (GGT), GOT/AST, GPT/ALT, NITROGENO UREICO SANGUINEO (BUN), PROTEÍNA C REACTIVA, ELECTROLITOS PLASMÁTICOS, TIEMPO DE PROTROMBINA (TP), TTPA, PERFIL HEMATOLÓGICO URGENCIA

Controlar laboratorio en 1 semana y evaluación con Dr. Martínez, hepatología.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Común

Medicamentos : Tramadol 100mg 1/2 Comprimido C/12 Hrs S.O.S.
Celecoxib 200 Mg 1 Comprimido C/12 Hrs X 10 Dias.

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Juan Ricardo Carvajal Alvarado

Médico Tratante (Staff)